

Cesárea — Indicaciones y complicaciones

1. Introducción y relevancia clínica

La **cesárea** es una intervención quirúrgica que consiste en **extraer el feto, la placenta y las membranas por una incisión en la pared abdominal y uterina**.

Su objetivo es **garantizar la seguridad materna y fetal** cuando el parto vaginal representa un riesgo mayor o es imposible.

En Chile, la tasa de cesáreas oscila entre **35 y 45% de los partos hospitalarios**, según el DEIS (MINSAL, 2023), cifra superior al ideal recomendado por la OMS (<15%), pero comparable con otros países latinoamericanos.

- En EUNACOM, las preguntas más frecuentes abordan:
 - Cuándo está indicada una cesárea.
 - Cuáles son sus tipos y complicaciones.
 - Cuándo se puede intentar un parto vaginal tras cesárea (PVDC).
 - Errores graves como el uso de misoprostol en útero cicatricial.
-

2. Fisiopatología y fundamentos quirúrgicos

El principio de la cesárea es **crear un acceso rápido y seguro al útero** para extraer al feto, minimizando la hemorragia y el trauma tisular.

Tipos de incisión:

1. Abdominal:

- **Transversa de Pfannenstiel (baja):** la más usada, estética y segura.
- **Media infraumbilical:** en emergencias o cirugía previa.

2. Uterina:

- **Segmentaria transversa baja (tipo Kerr):** estándar actual.

- **Vertical corporal (clásica):** solo en indicaciones excepcionales (placenta previa central, malformaciones uterinas, feto transverso difícil).

3. Clasificación según la urgencia

Tipo	Características	Ejemplo
Electiva (programada)	Indicaciones conocidas, sin urgencia	Cesárea iterativa, presentación podálica
De urgencia	Riesgo progresivo para madre o feto	Preeclampsia severa, detención del trabajo de parto
De emergencia	Riesgo inminente de muerte materno-fetal	Prolapso de cordón, desprendimiento de placenta

4. Indicaciones de cesárea

A. Obstétricas (mecánicas o funcionales)

Causa	Ejemplo
Desproporción cefalopélvica (DCP)	Cabeza no encajada, pelvis estrecha
Distocias del trabajo de parto	Detención de dilatación o descenso
Presentación anómala	Transversa, de cara mentoposterior, podálica

Placenta previa oclusiva

Placenta cubre el orificio cervical

Desprendimiento prematuro de placenta normoinsera (DPPNI)

Sangrado y sufrimiento fetal

Prolapso de cordón umbilical

Feto viable con bradicardia sostenida

B. Maternas

Condición	Justificación
Preeclampsia severa o eclampsia	Riesgo de convulsiones o edema pulmonar
Cardiopatía severa	Evitar pujo
Cirugía uterina previa tipo clásica	Riesgo de rotura uterina
Infección genital activa por herpes	Prevenir transmisión neonatal
Neoplasia cervical obstructiva	Bloqueo del canal de parto

C. Fetales

Condición	Justificación
------------------	----------------------

Sufrimiento fetal agudo

Evitar hipoxia irreversible

RCIU con alteración de flujos Doppler

Riesgo de asfixia

Embarazo múltiple con primer gemelo no cefálico

Mayor seguridad fetal

Macrosomía (>4.500 g en diabética)

Evitar distocia de hombros

Malformaciones fetales

Evitar trauma (mielomeningocele, hidrocefalia)

D. Cesárea iterativa

- Antecedente de **una cesárea previa segmentaria**:

Puede intentarse **parto vaginal después de cesárea (PVDC)** si se cumplen condiciones estrictas.

- Antecedente de **dos o más cesáreas previas**:

→ Indicación de **cesárea electiva**.

5. Criterios para parto vaginal después de cesárea (PVDC)

Según la Guía Perinatal MINSAL 2023:

✓ **Apto para PVDC si:**

- Cesárea previa **segmentaria transversa baja**.
- Motivo no recurrente (p. ej. sufrimiento fetal, presentación podálica).

- Embarazo único, cefálico, <4.000 g.
- Sin cicatriz uterina clásica o vertical.
- Hospital con disponibilidad quirúrgica inmediata.

XContraindicado PVDC si:

- Cesárea corporal o ≥ 2 previas.
- Inducción con prostaglandinas (misoprostol).
- DCP o desproporción previa.
- Cicatriz desconocida.

☐ En EUNACOM, el **uso de misoprostol en paciente con cesárea previa es un error grave** → riesgo alto de rotura uterina.

6. Técnica quirúrgica básica (resumen)

1. **Anestesia regional (raquídea o epidural).**
2. **Incisión abdominal transversa de Pfannenstiel.**
3. **Apertura de la pared uterina (segmento inferior).**
4. **Extracción fetal (maniobra de Kristeller o elevación).**
5. **Pinzamiento y sección del cordón.**
6. **Extracción de placenta y revisión uterina.**
7. **Cierre por planos anatómicos.**

Duración promedio: **30–45 minutos.**

7. Complicaciones

A. Inmediatas

Tipo	Ejemplo	Frecuencia
Hemorragia	Atonía, lesión vascular	5–10%
Infección	Endometritis, infección de herida	3–5%
Lesión vesical o intestinal	Por adherencias o técnica	<1%
Trombosis venosa profunda (TVP)	Inmovilidad, embarazo	1–2%
Reacción anestésica o broncoaspiración	Urgencias mal preparadas	Raro

B. Tardías

Tipo	Complicación	Descripción
Adherencias pélvicas	Dolor crónico, infertilidad	
Dehiscencia o rotura uterina	Riesgo en embarazos posteriores	
Placenta previa o percreta	Mayor riesgo con cada cesárea previa	
Cicatriz dolorosa o hernia incisional	Problema estético o funcional	

□ Cada cesárea previa **duplica el riesgo de placenta previa y triplica el de acretismo placentario.**

8. Complicaciones fetales

Complicación	Causa
Depresión neonatal (por anestesia o extracción brusca)	Retardo respiratorio
Trauma (fractura, corte accidental)	Maniobras o incisión
Taquipnea transitoria del RN	Falta de compresión torácica durante parto vaginal

9. Profilaxis y manejo perioperatorio

Etapas	Medidas
Preoperatorio	Profilaxis antibiótica (cefazolina 2 g EV antes de incisión)
Intraoperatorio	Control hemostático, aspiración suave, evitar trauma vesical
Postoperatorio	Oxitocina, analgesia, movilización precoz, compresión elástica
Anticoagulación profiláctica	Si factores de riesgo de trombosis

10. Cesárea en situaciones especiales

A. Cesárea de urgencia

Indicaciones:

- Sufrimiento fetal agudo.
- DPPNI.
- Prolapso de cordón.
- Ruptura uterina inminente.

→ Requiere extracción en <30 minutos desde la indicación.

B. Cesárea con placenta previa o acretismo

- Planificación con equipo multidisciplinario.
- Posible histerectomía obstétrica si hay acretismo severo.
- Banco de sangre disponible.

C. Cesárea en paciente con VIH

- Indicación si carga viral >1.000 copias/mL o desconocida.
- Si <1.000 copias/mL → parto vaginal posible.

11. Pronóstico y recuperación

- Reposición hídrica adecuada, analgesia y movilización precoz reducen complicaciones.
- Lactancia puede iniciarse en primeras 2 horas.
- Alta habitual a las 48–72 h.

□ En PVDC exitoso, la tasa de rotura uterina es <1%, pero debe realizarse solo en hospitales con capacidad quirúrgica 24 h.

12. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM



Perlas

1. Cesárea = extracción fetal por laparotomía + histerotomía.
2. **Tipo más usado:** segmentaria transversa baja (Kerr).
3. **Indicaciones más frecuentes:** DCP, sufrimiento fetal, placenta previa.
4. **Cesárea previa + misoprostol:** contraindicación absoluta.
5. **PVDC posible** solo con cesárea segmentaria baja y hospital preparado.
6. **Antibiótico profiláctico:** cefazolina 2 g EV antes de incisión.
7. **Complicación más frecuente:** hemorragia; **más grave:** rotura uterina o placenta acreta.



Errores comunes

- Usar prostaglandinas en paciente con cicatriz uterina.
- Intentar PVDC con cesárea clásica previa.
- Realizar incisión corporal sin indicación clara.
- No indicar antibiótico profiláctico.
- No vigilar signos de TVP ni fomentar movilización temprana.

13. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. **Cesárea:** extracción del feto por incisión abdominal y uterina.

2. **Indicaciones principales:** DCP, sufrimiento fetal, placenta previa, iterativa.
3. **Técnica habitual:** incisión segmentaria transversa baja (Kerr).
4. **Contraindicación de PVDC:** cesárea clásica, ≥ 2 previas o uso de misoprostol.
5. **Complicaciones:** hemorragia, infección, adherencias, placenta previa/accreta en futuros embarazos.
6. **Profilaxis:** cefazolina preoperatoria y oxitocina posparto.
7. **Misoprostol en útero cicatricial = error EUNACOM clásico.**